

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

CUESTIONARIO DE PREOCUPACIÓN DE PENN STATE (PSWQ)

Eje II: Procesos Psicológicos • Evaluación de la Preocupación Excesiva, Incontrolable y Generalizada

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL INSTRUMENTO

Nombre Oficial (Español)	Cuestionario de Preocupación de Penn State (PSWQ).
Nombre Original (Inglés)	<i>Penn State Worry Questionnaire (PSWQ)</i>
Autores Originales	Drs. T. J. Meyer, M. L. Miller, R. L. Metzger y T. D. Borkovec (1990), Pennsylvania State University.
Adaptaciones Españolas	Bonifacio Sandín, Paloma Chorot, Rosa M. Valiente y L. Lostao (2009); Ramos-Cejudo et al.
Eje Clínico y Clasificación	Eje II: Procesos Psicológicos. Modelo Cognitivo de la Preocupación Patológica (Borkovec).
Tipo de Instrumento	Autoinforme dimensional de 16 reactivos con escala Likert de 5 puntos (1 a 5).
Población y Rango	Adolescentes y adultos (desde los 13 años). Estándar en Trastorno de Ansiedad Generalizada (TAG).
Tiempo de Administración	3 a 5 minutos en autoadministración; 6 minutos asistido.
Régimen de Licencia	Instrumento científico abierto de libre distribución para uso clínico e investigación.

2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL Y MODELO DE EVITACIÓN DE BORKOVEC

El PSWQ es el estándar psicométrico internacional indiscutible para la cuantificación de la **preocupación patológica (worry)**. Diseñado por Thomas Borkovec y colaboradores, el instrumento evalúa las características nucleares de la preocupación clínica: su carácter excesivo, crónico, omnipresente, independiente del contexto y, de manera primordial, su **incontrolabilidad percibida**.

En el Modelo de Evitación Cognitiva de Borkovec, la preocupación se conceptualiza como una actividad verbal-lingüística abstracta orientada al futuro que funciona como una estrategia de afrontamiento encubierta: al pensar en palabras sobre posibles catástrofes, el individuo inhibe el procesamiento de imágenes mentales aversivas y bloquea la activación psicofisiológica simpática visceral completa, impidiendo la habituación y la extinción emocional natural. A nivel neurobiológico, refleja una hiperconectividad entre la corteza prefrontal dorsolateral izquierda (procesamiento fonológico del lenguaje interno) y la amígdala basolateral, atrapando al paciente en bucles perseverativos.

3. DOMINIOS EVALUADOS Y COMPOSICIÓN DE ÍTEMS

Componente de la Preocupación	Ítems (16)	Sentido	Definición Operativa y Fenomenológica Evaluada
1. Excesividad e Incontrolabilidad	2, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 16	Directos (11)	Percepción de incapacidad para frenar la preocupación, tendencia a preocuparse por todo y rumiación incesante.
2. Ausencia de Preocupación	1, 3, 8, 10, 11	Inversos (5)	Capacidad de desconectar de las preocupaciones, sosiego ante problemas resueltos y control atencional adaptativo.

PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS, BAREMOS Y CORRECCIÓN

4. VALIDEZ, CONFIABILIDAD Y RENDIMIENTO DIAGNÓSTICO EN ESPAÑA / LATAM

Consistencia Interna	Excepcional precisión: alfa de Cronbach de 0.91 a 0.95 en población española comunitaria y clínica (Sandín et al., 2009; Ramos-Cejudo et al.). Fiabilidad test-retest $r = 0.92$ a las 4 semanas.
Estructura Unidimensional	El AFC confirma una sólida dimensión general de preocupación patológica (los 5 ítems inversos configuran un artefacto de método por redacción pero no un constructo sustantivo separado).
Validez Concurrente y Específica	Correlación muy alta con síntomas de TAG (GAD-7, $r = 0.72$) y ansiedad rasgo (STAI-R, $r = 0.76$). Discrimina específicamente el TAG frente a otros trastornos de ansiedad (pánico, fobias).
Sensibilidad al Cambio	Estándar de oro para valorar la eficacia clínica en ensayos de TCC para TAG, mostrando descensos de gran tamaño de efecto ($d > 1.10$) tras terapia de control de estímulos y relajación aplicada.
Invarianza Demográfica	Invarianza métrica demostrada entre sexos; las mujeres obtienen puntuaciones medias normativas ligeramente superiores ($M = 48$ frente a $M = 44$ en varones).

5. REGLAS DE CORRECCIÓN Y CÁLCULO DE PUNTUACIONES

Cada uno de los 16 reactivos se responde de 1 a 5 (1 = «Nada característico de mí», 2 = «Poco característico», 3 = «Algo característico», 4 = «Bastante característico», 5 = «Totalmente característico»):

- **Paso 1 (Inversión Obligatoria de 5 Ítems):** Los reactivos **1, 3, 8, 10 y 11** deben invertirse: 1 → 5, 2 → 4, 3 → 3, 4 → 2, 5 → 1.
- **Paso 2 (Puntuación Total PSWQ):** Suma aritmética de los 11 ítems directos más los 5 ítems invertidos.
- **Rango Teórico: 16 a 80 puntos.** A mayor puntuación, mayor severidad de la preocupación patológica e incontrolable.

6. ESTRATIFICACIÓN CLÍNICA Y PUNTOS DE CORTE

Estratificación	Puntuación Total	Nivel de Preocupación	Conducta Asistencial Recomendada
Bajo / No Clínico	16 a 39 puntos	Preocupación adaptativa baja	Respuestas cognitivas proporcionadas ante problemas reales. Ausencia de rumiación o descontrol atencional.
Moderado	40 a 55 puntos	Preocupación moderada / reactiva	Vulnerabilidad ansiosa ante sobrecarga de estresores. Psicoeducación en higiene del sueño y resolución de problemas.
Alto / Clínico	56 a 64 puntos	Preocupación patológica (corte ≥ 56)	Criterio clínico compatible con TAG. Incontrolabilidad subjetiva manifiesta. Indicación de TCC especializada.
Severo / Extremo	65 a 80 puntos	Preocupación crónica invalidante	Parálisis por análisis, insomnio de conciliación severo, tensión muscular continua y grave interferencia funcional.

RENDIMIENTO DIAGNÓSTICO EN TAG (PUNTO DE CORTE ≥ 56):

En muestras clínicas hispanas, un puntaje en el **PSWQ ≥ 56 puntos** maximiza el índice de Youden para el diagnóstico de Trastorno de Ansiedad Generalizada (DSM-5), con una sensibilidad del 89% y especificidad del 85%. Puntuaciones por encima de 65 exigen descartar comorbilidad con depresión mayor secundaria o fobia social generalizada.

APLICACIÓN CLÍNICA, CASO ILUSTRATIVO Y REFERENCIAS

7. ALGORITMO DE DECISIÓN TERAPÉUTICA EN MANEJO DE LA PREOCUPACIÓN (TCC)

PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN EN TAG BASADO EN EL PSWQ:

- **Paso 1 (Control de Estímulos de Borkovec):** Romper la omnipresencia de la preocupación. Establecer un “período de preocupación” único de 20 minutos al día (ej. 18:00 a 18:20); posponer cualquier pensamiento intrusivo surgido a lo largo de la jornada hasta ese momento fijado.
- **Paso 2 (Exposición a la Incertidumbre):** Diferenciar problemas solubles actuales de catástrofes hipotéticas incontrolables. Para los primeros: resolución de problemas por pasos. Para los segundos: exposición en imaginación vívida sin verbalización neutralizadora.
- **Paso 3 (Monitorización):** Una reducción en el PSWQ de **≥ 10 puntos** al mes 2 indica recuperación del control voluntario y remisión de la tensión neurovegetativa.

8. CASO CLÍNICO ILUSTRATIVO: INTERVENCIÓN EN TRASTORNO DE ANSIEDAD GENERALIZADA

Paciente: Mujer de 37 años, profesora de educación primaria y madre de dos hijos, acude a consulta por contracturas trapeciales crónicas, colon irritable e insomnio de conciliación severo (tarda 3 horas en dormirse repasando hipotéticos accidentes infantiles o fallos en sus informes).

Evaluación Cuantitativa Inicial PSWQ: 71 / 80 puntos (Severidad clínica extrema; percentil 97).

• **Ítems Invertidos:** Ítem 1 = 1 (recodificado 5: nunca deja de preocuparse si no hay tiempo); Ítem 8 = 1 (recodificado 5: incapaz de descartar pensamientos); Ítem 11 = 1 (recodificado 5).

• **Ítems Directos Críticos:** Ítem 2 = 5 («Mis preocupaciones me desbordan»); Ítem 6 = 5; Ítem 15 = 5 («Me preocupo por todo»).

Formulación Clínica: TAG crónico sustentado por la creencia metacognitiva de que preocuparse es una obligación moral materna. La verbalización abstracta continua le impide procesar el miedo real y cronifica el insomnio.

Tratamiento y Evolución: TCC focalizada en TAG de 14 sesiones: período de preocupación acotado, relajación aplicada progresiva y reestructuración de la utilidad de la preocupación. Al finalizar, el PSWQ descendió a **42 puntos** (reducción clínica de 29 puntos), logrando conciliar el sueño en menos de 20 minutos.

9. ALERTAS CLÍNICAS Y GESTIÓN DIFERENCIAL

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: PREOCUPACIÓN VS. OBSESIÓN

En el PSWQ elevado (TAG), las preocupaciones son sintónicas, comprensibles temáticamente (familia, dinero, salud) y en formato discursivo verbal. En el TOC (OCI-R), las obsesiones son egodistónicas, mágicas o intrusivas, e inducen rituales compulsivos.

CAUTELA EN LA CODIFICACIÓN DE INVERSOS

Comprobar que los 5 reactivos inversos (1, 3, 8, 10, 11) se hayan recodificado adecuadamente (1 $\rightarrow$ 5). Omitir la inversión reduce el total medio en 15-20 puntos, generando un falso negativo en el cribado del TAG.

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS CIENTÍFICAS

1. Meyer, T. J., Miller, M. L., Metzger, R. L., & Borkovec, T. D. (1990). Development and validation of the Penn State Worry Questionnaire. *Behaviour Research and Therapy*, 28(6), 487–495.
2. Sandín, B., Chorot, P., Vallente, R. M., & Lostao, L. (2009). Validación española del Cuestionario de Preocupación de Penn State (PSWQ). *Revista de Psicopatología y Psicología Clínica*, 14(2), 107–122.
3. Borkovec, T. D., Ray, W. J., & Stöber, J. (1998). Worry: A cognitive phenomenon intimately linked to affective, physiological, and interpersonal behavioral processes. *Cognitive Therapy and Research*, 22(6), 561–576.
4. Molina, S., & Borkovec, T. D. (1994). The Penn State Worry Questionnaire: Psychometric properties and associated characteristics. *Worrying: Perspectives on theory, assessment and treatment*, 265–283.